

FREUD**I. Cas clinique 1 et 2 (1 à 20)**

Réponse exacte = +2 (Tous les items exacts). Réponse fausse ou Pas de réponse = 0 Pas de pénalité

Cas clinique n°1 :

Une sage-femme effectue le premier examen d'un nouveau-né. Elle découvre à la base du cordon ombilical une hernie des organes abdominaux, visible à travers une poche translucide. L'état général de l'enfant est stable, mais la sage-femme est consciente de la gravité de la situation et doit agir rapidement.

Questions à choix multiples (QCM) :

1. Quelle est la définition correcte de l'omphalocèle ?
 - a. Une hernie des organes abdominaux dans le sac scrotal.
 - b. Une hernie des organes abdominaux dans la base du cordon ombilical.
 - c. Une malformation des membres supérieurs.
 - d. Une hernie qui se fait à travers la paroi abdominale antérieure au niveau de l'ombilic.
2. Le diagnostic d'une omphalocèle est généralement évident :
 - a. Quelques jours après la naissance.
 - b. Lors de l'échographie anténatale.
 - c. Dès la naissance.
 - d. Seulement en présence d'une complication.
3. Le sac de l'omphalocèle est décrit comme étant :
 - a. Recouvert de peau.
 - b. Translucide et avasculaire.
 - c. Opaque et vasculaire.
 - d. Non visible à l'œil nu.
4. Quels sont les deux principaux risques associés à l'omphalocèle ?
 - a. La rupture et la nécrose.
 - b. L'infection et la desquamation.
 - c. La rupture et l'infection.
 - d. L'hémorragie et le choc.
5. Dans la conduite à tenir face à une omphalocèle, quelle action est considérée comme une urgence chirurgicale ?
 - a. L'application d'un pansement humide.
 - b. La libération des anses intestinales et leur réintégration dans l'abdomen.
 - c. La ligature du cordon ombilical.
 - d. L'application d'une solution de mercurochrome.

6. Quel est le rôle primordial de la sage-femme en cas d'omphalocèle ?

- a. De pratiquer immédiatement une réduction manuelle.
- b. D'établir un bilan sanguin complet de l'enfant.
- c. De protéger l'omphalocèle pour prévenir l'infection et d'expliquer la situation aux parents.
- d. De préparer l'enfant pour une transfusion sanguine.

7. Selon le document, l'omphalocèle est une malformation congénitale caractérisée par :

- a. Un arrêt de développement de la région ombilicale.
- b. Une surélévation de l'omoplate.
- c. Un rétrécissement de l'intestin.
- d. L'existence de côte surnuméraire.

8. Un des objectifs du traitement chirurgical est de :

- a. Augmenter le volume de la poche.
- b. Reconstituer la paroi abdominale.
- c. Laisser le sac se recouvrir de peau.
- d. Réaliser une résection de l'intestin.

9. Quelle est la méthode de traitement en plus de l'intervention chirurgicale ?

- a. L'application locale d'une solution aqueuse de mercurochrome, bétadine jaune ou rouge pour le tanage.
- b. L'utilisation d'un pansement compressif.
- c. La mise en place d'une sonde nasogastrique.
- d. Une période de restauration fonctionnelle.

10. Une petite hernie ombilicale chez un nouveau-né peut être méconnue lors de quel acte ?

- a. L'examen clinique.
- b. La ligature du cordon.
- c. L'alimentation.
- d. La pesée.

Cas clinique n°2 :

Lors d'une consultation de suivi à la maternité, une sage-femme examine un nouveau-né. Elle remarque une petite touffe de poils dans le bas du dos et note une asymétrie des plis fessiers. Ces observations l'alertent sur une possible malformation congénitale.

Questions à choix multiples (QCM) :

11. Quelle est la définition correcte du Spina-Bifida ?

- a. Un défaut de soudure des vertèbres dorsales.
- b. Un défaut de soudure des vertèbres cervicales.
- c. Un défaut de soudure des vertèbres lombaires.
- d. Une malformation des membres inférieurs.

12. Le défaut de fermeture du tube neural qui entraîne cette malformation se produit :

- a. Avant le 3ème mois de grossesse.
- b. Entre le 21ème et le 28ème jour de la grossesse.

- c. Au cours du deuxième mois de développement embryonnaire.
- d. Après la naissance.

13. La présence d'une touffe de poils est un signe d'une malformation qui ne prête pas à conséquence dans la plupart des cas. De quelle malformation s'agit-il ?

- a. La méningocèle.
- b. Le Spina-Bifida occulta.
- c. La myéloméningocèle.
- d. L'hydrocéphalie.

14. Quelle est la complication neurologique qui accompagne le plus souvent la myéloméningocèle ?

- a. La convulsion.
- b. L'irritabilité.
- c. L'hydrocéphalie.
- d. Le retard mental.

15. Qu'est-ce que la myéloméningocèle ?

- a. Une hernie des méninges qui ne contient pas la moelle épinière.
- b. Une hernie des méninges qui contient aussi la moelle épinière et des racines des nerfs.
- c. Un défaut de soudure des arcs vertébraux.
- d. Une simple faute dans les vertèbres.

16. En cas de méningocèle, quelle est la première action chirurgicale à réaliser ?

- a. La correction chirurgicale dans les 48 heures après la naissance.
- b. La correction chirurgicale dans les heures qui suivent la naissance.
- c. Le drainage vésical.
- d. Un traitement médicamenteux.

17. Quel est le rôle de la sage-femme en phase préopératoire d'une méningocèle ?

- a. Surveiller les signes d'hydrocéphalie.
- b. Apprendre aux parents à tenir l'enfant.
- c. Protéger l'excroissance, évaluer l'état de l'enfant et apporter un soutien moral aux parents.
- d. Effectuer une ponction lombaire.

18. Un des symptômes suivants n'est pas associé à l'hydrocéphalie, lequel ?

- a. L'augmentation du volume de la tête.
- b. La faiblesse générale.
- c. Le pied bot.
- d. L'irritabilité.

19. Le diagnostic du Spina-Bifida peut être fait au cours de la petite enfance si l'enfant présente :

- a. Des problèmes de contrôle des sphincters.
- b. Des troubles de la miction.
- c. Une touffe de poils.
- d. Une hernie.

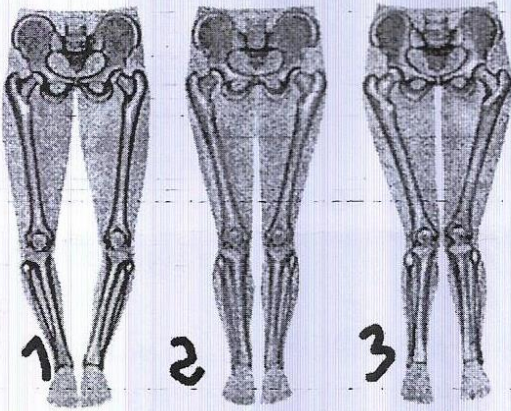
20. La correction chirurgicale de la myéloméningocèle doit être effectuée dans les 24 heures après la naissance pour éviter :

- a. La détérioration du système nerveux.
- b. L'apparition d'un hémangiome.
- c. L'asymétrie des plis fessiers.
- d. La surélévation de l'omoplate.

II. SCHÉMAS (Identifications) 21 à 24 : réponse juste = + 2 réponse fausse ou pas de réponse = 0

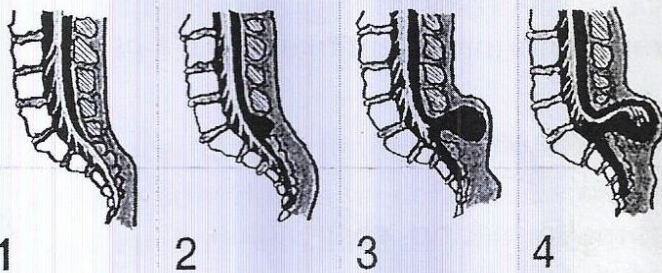
21. Concernant cette image, choisissez les propositions correctes:

- a. 1 correspond au genu varum
- b. 2 correspond au genu valgum
- c. 3 correspond au genu varum
- d. 3 correspond au genu valgum



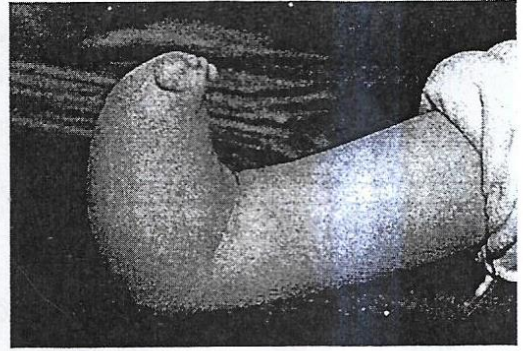
22. Concernant l'image ci dessous, choisissez les bonnes propositions

- a. 1 correspond à la spina bifida
- b. 2 correspond à la spina bifida occulta
- c. 3 correspond au mieloméningocèle
- d. 4 correspond au méningocèle



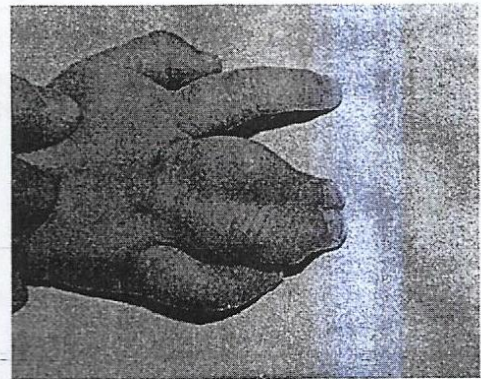
23. De quelle pathologie il est question ?

- A. Agénésie longitudinale
- B. Agénésie Transverse
- C. Omphalocèle
- D. Spina Bifida



24. De quelle pathologie il est question ?

- A. Agénésie longitudinal
- B. Syndactylie
- C. Spina Bifida
- D. Agénésie transverse



III. QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD) (25 à 39)

Réponse exacte = + 1 Réponse fausse = -1 Pas de réponse = 0

Enoncé vrai = A Enoncé faux = B

- 25. La syndactylie est la déviation permanente de la main sur l'avant-bras
- 26. Le traitement des malformations ano-rectales est chirurgical
- 27. L'ischion se définit comme étant chacune des parties postéro-inférieures des os iliaques
- 28. L'omphalocèle est une hernie des organes abdominaux dans la base du cordon ombilical
- 29. Le genu valgum est une déviation des jambes en dedans et des genoux en dehors
- 30. L'hémimélie tibiale est une aplasie et une hypoplasie tibiales
- 31. L'ectopie testiculaire est généralement droite que gauche
- 32. Une échographie abdominale est conseillé en cas d'ectopie testiculaire
- 33. La spina bifida est un défaut de fermeture des vertèbres sacrées
- 34. Le testicule récurrent est un testicule qui a franchi normalement mais qui n'a pas pu pénétrer dans le scrotum
- 35. La trisomie 21 apparaît pendant la période embryonnaire
- 36. La foetoscopie est type de prélèvement maternel
- 37. L'exposition aux radiations peut entraîner des malformations congénitales
- 38. Le Genu Varum est la déviation des cuisses en abduction
- 39. L'occlusion aigüe neonatale peut avoir plusieurs sièges

IV. QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (QCM) 40 à 49

Réponse exacte = +2 (Tous les items exacts). Réponse fausse ou Pas de réponse = 0 Pas de pénalité

40. Dans une occlusion aiguë neonatale, l'attention de l'infirmier doit être attiré par

- a. Vomissement
- b. Fièvre
- c. Diarrhée
- d. Absence de meconium

41. Dans la cryptorchidie, le testicule est

- a. Présent dans la bourse mais absent dans l'axe péritonéo-vaginal
- b. Absent de la bourse mais présent dans l'axe péritonéo-vaginal
- c. Présent dans la bourse et présent dans l'abdomen
- d. Absent de la bourse mais présent dans le scrotum

42. L'Union de deux ou plusieurs doigts surtout au niveau des parties de leur longueur est appelée

- a. Doigts accolés
- b. Polydactylie
- c. Syndactylie
- d. Doigts collés

43. Une absence d'un segment transversal de membre est appelée

- a. Manchot
- b. Main réduite
- c. Agénésie transverse
- d. Ante-brachie

44. Concernant les difformités du membre inférieur

- a. Le genu varum présente des membres inférieurs sous forme de V
- b. Le genu valgum présente des membres inférieurs sous forme de X
- c. Le fémur normal est perpendiculaire à la cavité cotyloïde
- d. La luxation congénitale de la hanche se rencontre souvent chez les enfants nés par le siège

45. Concernant les fentes labio palatine

- a. Elles sont dues à un défaut de soudure des bourgeons embryonnaires au cours des premières semaines de l'embryogenèse
- b. Elles sont les malformations congénitales les plus fréquentes au niveau du visage
- c. Leurs prises en charge est unidisciplinaire

d. Elles sont souvent associées au bec de lièvre

46. La triade symptomatologique de l'occlusion aigue neonatale est composé de

- a. Fièvre
- b. Douleur
- c. Arrêt des matières et des gaz
- d. Vomissement

47. Parmi les malformations ci-dessous citées, une seule relève d'un défaut de soudure des arcs vertébraux postérieurs, laquelle ?

- a. Méningocèle
- b. Spina bifida occulta
- c. Myelomeningocele
- d. Ataxie

48. Dans les omphalocèles, il existe deux (02) principaux risques.

- a. La déshydratation
- b. La rupture
- c. La nécrose
- d. L'infection

49. Choisir les réponses correctes

- a. L'embryogenèse a lieu entre la fécondation et la 12 SA
- b. La période fœtale dure de la fécondation au terme
- c. L'organogenèse débute pendant l'embryogenèse
- d. Les maladies génétiques sont formées avant la fécondation